

Nadmierna odpowiedzialność

Wszyscy mamy intruzje. To, co przekształca je w OCD, to przekonanie „jestem za to odpowiedzialny/-a — i muszę zapobiec”.

CZAS: 10 min czytania Fundament psychoedukacji ERP

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1985, 1999, *Behav Res Ther*); Rachman (1997, 1998); NICE CG31 (2005)

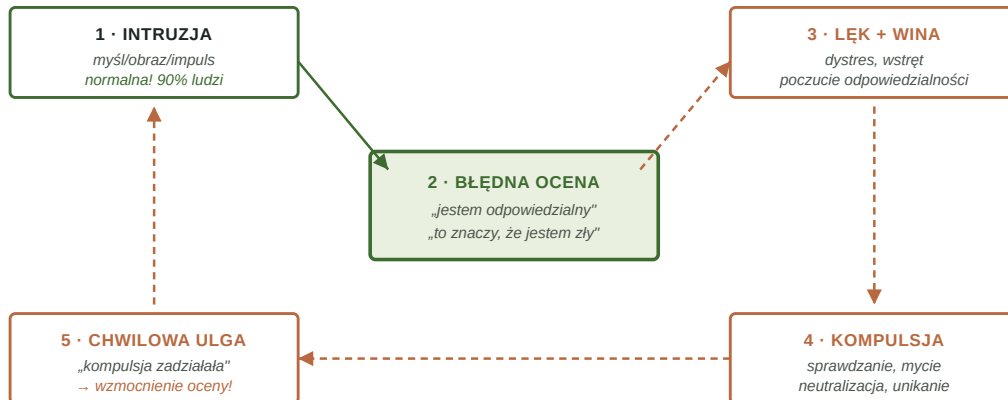
JAK UŻYWAĆ

Zrozum **cykl 4-elementowy** modelu Salkovskisa: intruzja → błędna ocena → lęk/wina → kompulsja. Rdzeniem oceny jest **nadmierna odpowiedzialność**: „jeśli pomyślałem coś złego i nie zapobiegłem — to moja wina”. To *nie myśl* jest problemem, lecz interpretacja tego, co znaczy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Paul Salkovskis (1985, 1999, *Behaviour Research and Therapy*): **pierwsza spójna teoria CBT dla OCD**. Kluczowe odkrycie poprzedzające: Rachman i de Silva (1978) — **90% populacji bez OCD** doświadcza intruzji o tej samej treści, co osoby z OCD. Różnica nie w myśli, lecz w jej *ocenie*. Salkovskis pokazał, że to nadmierna odpowiedzialność („inflated responsibility”) jest najczęstszym **rdzeniem patologizującym** intruzję. Model jest dziś podstawą leczenia OCD pierwszej linii (NICE CG31, 2005; APA, 2007) — z technikami ERP, restrukturyzacji odpowiedzialności i defuzji.

01 {} Cykl 4-elementowy



Klucz Salkovskisa: elementy 1 (intruzja) i 5 (chwilowa ulga) są *nieuniknione*. To, co można zmienić, to **element 2** — interpretację intruzji. ERP atakuje element 4 (powstrzymanie kompulsji), restrukturyzacja poznawcza — element 2 (zmiana oceny).

02 ☉ Nadmierna odpowiedzialność — rdzeń

WZÓR OCD

„Skoro **pomyślałem** o krzywdzie — odpowiadam, by jej zapobiec. Każda możliwa szkoda obciąża *mnie*”.

Skutek: kompulsje jako „**obowiązek** obronny” — kontrola, sprawdzanie, modlitwy neutralizujące.

WZÓR BEZ OCD

„Pomyślałem coś dziwnego — **dziwne myśli się zdarzają**. Idę dalej”.

Skutek: intruzja przechodzi w **30-60 sekund** i jest zapomniana. Brak kompulsji, brak wzmocnienia.

03 Twój cykl — wypełnij

1 · KONKRETNA INTRUZJA

— myśl/obraz, który mnie dręczy

2 · CO TA MYŚL DLA MNIE ZNACZY

— jaką ocenę wystawiam

3 · CO CZUJĘ — LĘK, WINA, WSTRĘT

— skala 0–10

4 · CO ROBIĘ, BY SIĘ USPOKOIĆ

— moja typowa kompulsja

5 · JAK DŁUGO TRWA ULGA

— minuty, godziny — i potem co?

04 Trzy główne wzorce błędnej oceny

A · INTRUZJA JAKO ZAGROŻENIE

„Ta myśl pokazuje, że **coś złego się stanie**”. *Technika*: obliczanie realnego prawdopodobieństwa, ekspozycja in vivo.

B · INTRUZJA JAKO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

„Skoro pomyślałem, **jestem odpowiedzialny**, by zapobiec”.
Technika: tort odpowiedzialności, dwa standardy.

C · MYŚL–DZIAŁANIE (TAF)

„**Pomyśleć = zrobić**; pomyśleć = chcieć”. *Technika*: eksperyment fuzji TAF, defuzja.

Klucz: Salkovskis (1999): „w OCD problem nie leży w myśli, lecz w tym, co pacjent myśli o tej myśli”. Ekspozycja bez tej psychoedukacji wydaje się „zachęcaniem do robienia czegoś niebezpiecznego” — z nią ma jasny cel: *testowanie błędnej oceny*. NICE CG31 (2005) i APA (2007) rekomendują CBT z ERP oparte na tym modelu jako **leczenie pierwszej linii**. Każda kompulsja, której się powstrzymujesz, *uczy mózg*: „obsesja nie była zagrożeniem — bo nie zrobiłem nic, a katastrofa nie nastąpiła”.